

I Disturbi di Personalità

Salute Mentale · Sessione 08 · 15.04.2026

Questa lezione è una delle più dense del modulo — e anche una delle più utili per il lavoro sul campo. Si parla di come siamo fatti dentro, di dove finisce la "normalità" e dove inizia il "disturbo", e di quali categorie esistono per orientarsi. Resta fino alla fine: il borderline è qualcosa che incontrerai spesso nel lavoro sociale.

Le origini della personalità: temperamento, carattere e personalità

Temperamento

Il **temperamento** è la base biologica della nostra personalità. Il termine viene dai grandi medici greci **Ippocrate e Galeno**, che descrivevano quattro tipi: sanguigno, melanconico, colerico e flemmatico. In termini moderni, è l'insieme dei tratti **congeniti** (biologicamente determinati e presenti dalla nascita) che stabiliscono il *modo emotivo* con cui una persona risponde al mondo esterno (**Paris, 1997**).

Il temperamento è relativamente stabile, ma non del tutto immutabile. **È influenzato anche da fattori prenatali e perinatali: l'esposizione prenatale a ormoni dello stress materni, per esempio, può alterare la programmazione della risposta allo stress del bambino per tutta la vita** (**Sandman et al., 2011; Nazzari et al., 2019**).

Thomas, Chess & Birch (1968) hanno individuato **nove variabili temperamentali** osservabili fin dalla nascita:

Variabile	Cosa descrive
Livello di attività	Quantità di movimento e energia fisica spontanea
	Prevedibilità di sonno, alimentazione, defecazione

Variabile	Cosa descrive
Regolarità dei ritmi biologici	
Approccio/Ritiro	Come il bambino reagisce alle novità e agli stimoli nuovi
Adattabilità	Capacità di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente
Sensibilità agli stimoli fisici	Soglia di risposta agli stimoli sensoriali
Intensità delle reazioni	Quanto intensamente il bambino esprime emozioni
Qualità dell'umore	Prevalenza di stati d'animo positivi o negativi
Distraibilità	Quanto facilmente il bambino viene distolto da un'attività
Persistenza	Quanto a lungo si concentra su un compito nonostante le difficoltà

Dalla combinazione di queste variabili emergono tre grandi tipologie di bambini: - **Bambini "facili"**: ritmi regolari, umore prevalentemente positivo, buona adattabilità - **Bambini "difficili"** (~10% del campione): caratteristiche opposte, più complicati - **Bambini a "lenta attivazione"**: risposte meno intense alle novità, adattamento lento

Un bambino più irritabile suscita nell'ambiente risposte meno positive. Come sottolinea la lezione, è più complicato essere "madrì sufficientemente buone" (Winnicott) con un figlio dalla dotazione temperamentale difficile — non è colpa di nessuno, è una danza bilaterale.

Questo concetto viene chiamato **goodness of fit**: il grado in cui le caratteristiche temperamentalì di una persona si armonizzano con quelle del proprio ambiente (Thomas & Chess, 1977). La qualità della relazione di attaccamento dipende sia dal temperamento del bambino sia dalle risposte della madre.

Carattere

Il **carattere** (dal greco *kharàssein*, "incidere, marchiare") è l'insieme dei tratti psicologici e comportamentali stabili che si sviluppano quando il bambino con il suo temperamento innato entra in contatto con l'ambiente. Viene "modellato" dalle relazioni e dalle esperienze di vita.

Attenzione: l'ambiente che conta non è quello visto dall'esterno, ma quello *percepito* dal bambino. Per questo due fratelli cresciuti nella stessa famiglia possono sviluppare personalità molto diverse. La caratteristica principale di un tratto è la **stabilità**: appare in modo costante e coerente nel tempo e in situazioni diverse.

Un **tratto** si contrappone allo **stato**, che è una condizione temporanea scatenata da eventi esterni (es. **una depressione reattiva**, **un attacco di panico**). Da qui una distinzione clinica fondamentale:

- **Disturbi di personalità** → derivano da *tratti* abnormi (stabili, pervasivi)
- **Sindromi cliniche** → derivano da *stati* abnormi (possono essere circoscritte nel tempo)

Personalità

La **personalità** è il risultato dell'interazione tra temperamento e carattere. Il termine deriva dal latino *persona*, la maschera degli attori nel teatro romano — qualcosa che parte dall'interno e arriva all'esterno, amplificando la voce verso il pubblico.

La definizione più usata (Lingiardi & McWilliams, 2018) descrive la personalità come:

"Un insieme di modalità relativamente stabili di **pensare, sentire, comportarsi e mettersi in relazione con gli altri.**"

Queste quattro dimensioni sono il cuore: come interpretiamo noi stessi e il mondo (*pensare*), quale repertorio emotivo usiamo e come gestiamo le emozioni (*sentire*), come agiamo (*comportarsi*), e come interagiamo con gli altri (*mettersi in relazione*).

Importante: la personalità non è rigidamente fissa — evolve nell'arco della vita. Tuttavia le *dinamiche di fondo* rimangono stabili e si attivano in base al contesto. Le persone con una patologia narcisistica, per esempio, possono diventare rabbiose quando si sentono sminuite, ma essere cooperative e affidabili quando si sentono apprezzate.

Dai modelli di tratti alla psicopatologia

Il modello di Eysenck

Hans Eysenck (1916-1997) identificò tre fattori principali della personalità, misurabili con un questionario:

- 1. **Estroversione** vs Introversione: quantità e intensità dei contatti interpersonali
- 2. **Nevroticismo** vs Stabilità emotiva: tendenza all'instabilità e al turbamento emozionale
- 3. **Psicoticismo**: basso coinvolgimento nei rapporti interpersonali (concetto controverso, non ripreso nelle classificazioni successive)

Il modello Big Five (Costa & McCrae, 1988)

Il modello a **cinque fattori** (Costa & McCrae, 1988) aggiunge a estroversione e nevroticismo altri tre:

Fattore	Polo positivo	Polo negativo
Gradevolezza	Calore, cooperazione, cordialità	Egoismo, cinismo, freddezza
Coscientiosità	Organizzazione, affidabilità, persistenza	Impulsività, disorganizzazione
Apertura all'esperienza	Curiosità, immaginazione, ricerca del nuovo	Inibizione, convenzionalità

Ogni tratto è un continuum bidimensionale — nessuno sta a un estremo puro.

La corazza caratteriale (Wilhelm Reich)

Reich (1897-1957) coniò il concetto di **corazza caratteriale**: i caratteristici stili difensivi che le persone usano per proteggersi dall'angoscia e dai pericoli del mondo. **La personalità sarebbe determinata in gran parte dal proprio peculiare modo di difendersi.**

La lezione usa un esempio efficace: immagina una bambina su un seggiolone. Lì è al sicuro. Ma per crescere, prima o poi il seggiolone va rimosso. La corazza caratteriale funziona allo stesso modo: formata nei primi anni di vita perché *funzionale* in quel momento, può diventare un limite nell'età adulta.

Quando le difese sono **rigide, inflessibili e pervasive**, invece di aiutare bloccano — ed è da questa rigidità che nascono i disturbi di personalità. (Perry, Presniak & Olsen, 2013; McWilliams, 1994)

Dagli stili ai disturbi di personalità

Stile vs. Disturbo

Tutti noi abbiamo tratti che si discostano dalla media. Questo non significa avere un "disturbo". La differenza sta nel grado di rigidità e nelle conseguenze sulla vita:

- **Stile di personalità**: tratti presenti ma relativamente adattivi, non tali da compromettere il funzionamento. **Es: una persona con personalità ossessiva ma funzionale nel lavoro.**
- **Disturbo di personalità**: i tratti sono così estremi e disadattivi da causare sofferenza e compromissione significativa.

Il caso dell'impiegato postale Sam — che funzionava benissimo finché non fu promosso a ruolo di dirigente — mostra che **anche le circostanze sociali determinano se un tratto diventa disturbo.** (Sims, 2009; Schneider, 1958)

Il modello bio-psico-sociale (Paris, 1997)

L'eziopatogenesi dei disturbi di personalità si capisce con un modello integrato (Paris, 1997):

- **Fattori biologici:** aspetti ereditari del temperamento, disfunzioni neuropsicologiche
- **Fattori psicologici:** esperienze traumatiche, stili abnormi di accudimento familiare
- **Fattori sociali:** disgregazione dei valori, perdita di tappe iniziatiche nella crescita

La **diatesi** (vulnerabilità innata) determina il tipo di patologia, mentre i **fattori stressanti** attivano questo potenziale. Nessun fattore prevale sugli altri — solo la loro interazione cumulativa spiega lo sviluppo dei disturbi.

La definizione del DSM-5-TR

Il **Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali** (DSM-5-TR, APA, 2023) definisce il disturbo di personalità come:

"Un pattern abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo, è pervasivo e inflessibile in un'ampia varietà di situazioni personali e sociali, determina disagio clinicamente significativo o compromissione in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti, è stabile o di lunga durata e **esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta.**"

Lo schema ricorrente si manifesta in almeno **due** di queste aree: 1. Cognitività (come percepisce sé, gli altri, gli avvenimenti) 2. Affettività (varietà, intensità, labilità della risposta emotiva) 3. Funzionamento interpersonale 4. Controllo degli impulsi

Tre aspetti chiave da tenere a mente:

- **Culturale:** i disturbi vanno valutati nel contesto culturale dell'individuo — un immigrato in una nuova cultura può sembrare "disturbato" senza esserlo davvero.
- **Egosintonico:** spesso la persona non percepisce i propri tratti come problematici (*tratti egosintonici*). Per questo è difficile portarla in terapia.
- **Pervasivo:** il pattern deve manifestarsi in molte situazioni diverse, non in un solo contesto.

Spettro internalizzante vs esternalizzante

Spettro	Caratteristica	Esempi di diagnosi
Internalizzante	Sofferenza vissuta interiormente; si incolpano sé stessi	Dipendente, evitante, ossessivo-compulsivo, schizoide
Esternalizzante	Sofferenza fatta patire agli altri; si incolpano gli altri	Istrionico, narcisistico, paranoide, antisociale
Borderline	Oscillazione continua tra i due spettri	—

Fin qui ci siamo? Bene. Ora viene la parte del catalogo — i tre cluster. È quella che serve per l'esame.

I tre cluster del DSM

Cluster A — "Strani ed eccentrici"

Caratteristica comune: apparire strani o eccentrici, diffidenza, tendenza all'isolamento.

Disturbo Paranoide di Personalità

Nucleo: diffidenza e sospettosità pervasive — le motivazioni degli altri vengono interpretate come malevole.

Criteri principali (APA, 2023): - Sospetta senza fondamento di essere sfruttato, danneggiato o ingannato - Non si confida per paura che le informazioni vengano usate contro di lui/lei - Porta costantemente rancore - Percepisce attacchi al proprio ruolo non evidenti agli altri e reagisce con rabbia - Sospetta della fedeltà del partner senza motivo

Credenza su sé stesso: "Sono costantemente in pericolo" **Credenza sugli altri:** "Il mondo è pieno di persone pronte ad attaccarmi o usarmi" **Meccanismi difensivi:** Proiezione; identificazione proiettiva; diniego; formazione reattiva (Lingiardi & McWilliams, 2018)

La lezione usa l'esempio del martello: un uomo si convince progressivamente, lungo il tragitto verso casa del vicino, che questi si rifiuterà di prestarglielo, che ce l'ha con lui — e quando il vicino apre, gli grida "tenga pure il suo martello, villano!" prima ancora di sentire una parola. Questo è l'identificazione proiettiva in azione: si proietta sull'altro una rabbia/paura interna, poi si agisce come se l'altro l'avesse davvero causata.

Queste persone, a livelli patologici, possono diventare leader pericolosi: trovano un "nemico comune" e aggregano attorno a sé chi condivide la stessa paura.

Disturbo Schizoide di Personalità

Nucleo: distacco pervasivo dalle relazioni sociali e gamma ristretta di espressioni emotive.

Criteri principali (APA, 2023): - Non desidera né prova piacere nelle relazioni strette - Quasi sempre sceglie attività solitarie - Non ha amici stretti o confidenti (a parte parenti stretti) - Appare indifferente alle lodi o alle critiche - Freddezza emotiva e affettività ristretta

Credenza su sé stesso: "La dipendenza e l'amore sono pericolosi" **Credenza sugli altri:** "La vita sociale mi invade e mi fa sentire pericolosamente sopraffatto" **Meccanismo difensivo:** Ritiro (comportamentale e in fantasia)

Disturbo Schizotipico di Personalità

Nucleo: deficit sociali e interpersonali + distorsioni cognitive e percettive + eccentricità di comportamento.

Criteri principali (APA, 2023): - **Idee di riferimento** (eventi casuali sembrano riferiti a lui/lei) - Pensiero magico o strane credenze (**credere di poter influenzare le persone col pensiero**) - **Esperienze percettive insolite** (sentire presenze, illusioni) - Pensiero e linguaggio strani - Sospettosità o ideazione paranoide - Comportamento o aspetto bizzarro

È il disturbo di personalità **più vicino all'ambito psicotico** — ma il contatto con la realtà è ancora presente (seppur labile). Non ci sono deliri veri e propri.

Cluster B — "Drammatici, emotivi, imprevedibili"

Caratteristica comune: difetto nella regolazione emotiva, scarso controllo degli impulsi.

Disturbo Antisociale di Personalità

Nucleo: pattern pervasivo di inosservanza e violazione dei diritti degli altri.

Criteri principali (APA, 2023): - Non si conforma alle norme sociali (condotte passibili di arresto) - Menzogne, truffe, false identità - Impulsività, incapacità di fare piani - Irritabilità e aggressività (scontri fisici) - Negligenza per la sicurezza propria e altrui - Irresponsabilità cronica - **Assenza di rimorso**

Criterio specifico: il disturbo della condotta deve essersi evidenziato **prima dei 15 anni**. Segnali precoci gravi: crudeltà verso gli animali, incendi dolosi.

Credenza su sé stesso: "Posso fare tutto ciò che voglio" **Credenza sugli altri:** "Sono tutti egoisti, spregevoli o incapaci di farsi valere" **Meccanismo difensivo:** Controllo onnipotente

Disturbo Borderline di Personalità (BPD)

Nucleo: instabilità pervasiva nelle relazioni interpersonali, nell'immagine di sé e nell'umore, con marcata impulsività.

Rappresenta circa il **20% dei pazienti** psichiatrici (Gunderson & Links, 2015).
Marsha Linehan lo descrive così:

"Gli individui borderline sono l'equivalente psicologico dei pazienti con ustioni di terzo grado. Semplicemente non hanno, per così dire, una pelle emozionale."

Criteri principali (APA, 2023):

1. **Sforzi disperati per evitare l'abbandono** (reale o immaginario): senza un altro accanto, la persona sente il vuoto — come se l'altro servisse a "sentirsi vivi". È la costanza dell'oggetto che manca: se l'altro non è davanti agli occhi, c'è il vuoto.
2. **Relazioni interpersonali intense e instabili:** alternanza di iperidealizzazione e svalutazione — "sei il migliore del mondo" / "sei il peggiore" nello spazio di una serata.
3. **Alterazione dell'identità:** senso di sé instabile e persistentemente discontinuo. Non sa cosa gli piace, i valori cambiano, anche le preferenze sessuali possono oscillare.
4. **Impulsività** in aree potenzialmente dannose: spese, sessualità, sostanze, guida spericolata, abbuffate.
5. **Comportamenti automutilanti o minacce suicidarie:** presenti nell'80% dei ricoverati con BPD. L'autolesionismo può: arginare il dolore psicologico, concretizzare emozioni altrimenti inesprimibili, comunicare una richiesta d'aiuto.
6. **Instabilità affettiva:** umore che cambia da un minuto all'altro (diversa dal disturbo bipolare, che ha cicli molto più lunghi).

7. **Sentimenti cronici di vuoto.**

8. **Rabbia inappropriata e intensa:** lo stato rabbioso è il più frequente.

9. **Ideazione paranoide transitoria** o sintomi dissociativi in momenti di forte stress — soprattutto associati alla (anche solo immaginata) perdita di qualcuno.

Credenza su sé stesso: "Non so chi sono: mi sento confuso, dissociato, privo di continuità" **Credenza sugli altri:** "Gli altri sono tutti buoni o tutti cattivi"

Meccanismi difensivi: **Scissione**; identificazione proiettiva; diniego; dissociazione; acting out; altre difese primitive (**Lingiardi & McWilliams, 2018**)

La lezione mostra estratti da un documentario su una donna con BPD. Nel primo, le viene chiesto di leggere una lettera sui sentimenti verso il fratello — e invece di farlo, inizia a lamentarsi della fontanella d'acqua, poi accusa la terapeuta, poi denuncia lo spazio fisico. È l'identificazione proiettiva in azione: non riesce a stare nel dolore emotivo, lo sposta sull'altro per farlo provare a lui.

Disturbo Istrionico di Personalità

Nucleo: emotività eccessiva e ricerca pervasiva di attenzione.

Criteri principali (**APA, 2023**): - Disagio quando non è al centro dell'attenzione - Comportamento sessualmente seduttivo o provocante ma inappropriato - Emotività mutevole e superficiale - Usa l'aspetto fisico per attirare attenzione - Eloquio eccessivamente impressionistico e privo di dettagli - Drammatizzazione, teatralità, emozioni esagerate - Suggestionabilità - Considera le relazioni più intime di quanto non siano realmente

Disturbo Narcisistico di Personalità

Nucleo: grandiosità (nella fantasia o nel comportamento), necessità di ammirazione, mancanza di empatia.

Criteri principali (**APA, 2023**): - Senso grandioso di importanza (esagera risultati e talenti) - Fantasie di successo illimitato, potere, fascino, bellezza - Si ritiene "speciale" e unico - Richiede eccessiva ammirazione - Senso che tutto gli sia dovuto

- Sfruttamento interpersonale - **Mancanza di empatia**: distingue *empatia cognitiva* (capisce razionalmente cosa prova l'altro) da *empatia emotiva* (entra in risonanza affettiva con l'altro) — qui manca la seconda - Invidia verso gli altri o convinzione che gli altri lo invidino - Comportamenti arroganti e presuntuosi

Credenza su sé stesso: "Devo essere perfetto per sentirmi bene" **Credenza sugli altri**: "Gli altri hanno ricchezza, potere e fama — più ne avrò anch'io e meglio starò" **Meccanismi difensivi**: Idealizzazione e svalutazione (Lingiardi & McWilliams, 2018)

La lezione sottolinea un punto importante: dietro la facciata di grandiosità c'è spesso un'autostima estremamente fragile e vulnerabile. La grandiosità è una corazza — "non ho bisogno degli altri, basto a me stesso" — costruita probabilmente perché nella storia precoce mostrare debolezza era intollerabile. Chi idealizza, svaluta — sempre.

Cluster C — "Ansiosi e inibiti"

Caratteristica comune: ansia, inibizione, scarsa autostima.

Disturbo Evitante di Personalità

Nucleo: inibizione sociale pervasiva, sentimenti di inadeguatezza, ipersensibilità al giudizio negativo.

Criteri principali (APA, 2023): - Evita attività con contatto interpersonale per paura di critiche o rifiuto - Riluttante ad entrare in relazione se non è certo di piacere - Riservato nelle relazioni intime per paura di essere umiliato - Si vede come socialmente incapace, privo di fascino o inferiore - Riluttante ad assumere rischi o intraprendere nuove attività per paura dell'imbarazzo

Distinzione cruciale: queste persone *desiderano* le relazioni — è questo che le distingue dagli schizoidi, che non le vogliono. È la paura del rifiuto a tenerle lontane. Molto vicino all'ansia sociale, ma diverso: qui è un pattern stabile di personalità, non una fobia situazionale.

Credenza su sé stesso: "Sono in costante pericolo e devo fare di tutto per evitarlo" **Credenza sugli altri:** "Gli altri sono una fonte di pericolo o dei protettori salvifici" **Meccanismi difensivi:** Simbolizzazione; spostamento; evitamento; razionalizzazione; ansia indefinita ([Lingiardi & McWilliams, 2018](#))

Disturbo Dipendente di Personalità

Nucleo: necessità pervasiva ed eccessiva di essere accuditi, con comportamento sottomesso e timore della separazione.

Criteri principali ([APA, 2023](#)): - Non riesce a prendere decisioni quotidiane senza consigli e rassicurazioni eccessive - Ha bisogno che gli altri si assumano le responsabilità principali - Non esprime il dissenso per paura di perdere il supporto - Si offre volontariamente per compiti spiacevoli pur di mantenere l'attenzione - Si sente smarrito se solo - Quando finisce una relazione, ricerca immediatamente un'altra fonte di cura

Credenza su sé stesso: "Sono inadeguato, debole, bisognoso, impotente"

Credenza sugli altri: "Gli altri sono forti e potenti, e io ho bisogno delle loro cure"

Meccanismi difensivi: Regressione; capovolgimento dell'affetto; evitamento; somatizzazione ([Lingiardi & McWilliams, 2018](#))

Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità (DOCP)

Nucleo: preoccupazione pervasiva per l'ordine, perfezionismo e controllo mentale e interpersonale, a spese di flessibilità ed efficienza.

Criteri principali ([APA, 2023](#)): - Eccessiva attenzione per dettagli, regole, ordine — al punto che lo scopo principale dell'attività va perduto - Perfezionismo che interferisce con il completamento dei compiti - Dedizione eccessiva al lavoro a scapito del tempo libero - Eccessiva coscienziosità e inflessibilità morale - Accumula oggetti anche di nessun valore - Riluttanza a delegare - Stile di vita privo di generosità; denaro da accumulare per catastrofi future - Rigidità e ostinazione

Differenza fondamentale con il DOC (disturbo ossessivo-compulsivo): nel DOCP non ci sono ossessioni (pensieri intrusivi ripetitivi) né compulsioni (azioni

rituali ripetute). È un *modo di vivere* — e spesso la persona non si rende conto dell'effetto che ha sugli altri (*egosintonico*).

La lezione mostra un estratto dal film *Bianco, rosso e Verdone*: un personaggio ipercontrollante che telefona all'ACI per sapere se riuscirà a superare il fronte perturbativo prima di arrivare a Parma, e che detta una lista di preparativi minuziosi alla moglie — senza rendersi conto di come la stia opprimendo.

Credenza su sé stesso: "La maggior parte delle emozioni è pericolosa e va tenuta sotto controllo" **Credenza sugli altri:** "Gli altri sono meno precisi di me e devo controllare quello che fanno" **Meccanismi difensivi:** Isolamento degli affetti; formazione reattiva; intellettualizzazione; moralismo; annullamento retroattivo (Lingiardi & McWilliams, 2018)

Il problema dei sistemi diagnostici

Il DSM usa un approccio **categoriale** (presenza/assenza), ma i disturbi psicologici hanno natura **dimensionale** (un continuum). Questo crea problemi reali in clinica.

1. **Alta comorbidità:** nello studio di Shea et al. (1999) su veterani di guerra e donne sopravvissute ad abusi, l'82-90% soddisfaceva i criteri per il disturbo paranoide, il 52-92% per quello borderline — categorie teoricamente distinte che si sovrappongono enormemente nella realtà.
2. **Casi sotto soglia:** chi ha tratti significativi ma non raggiunge il numero minimo di criteri viene "tagliato fuori".
3. **Artificiosità delle categorie:** "Sembra paradossale dover porre più diagnosi di disturbo di personalità dal momento che quest'ultima è, per definizione, l'insieme complessivo delle caratteristiche di un individuo." (Giacchetti, Aceti & Meuti, 2000)

Il **PDM-2** (Psychodynamic Diagnostic Manual, Lingiardi & McWilliams) propone un approccio più dimensionale e più vicino alla realtà clinica.

L'organizzazione di personalità secondo Kernberg

Storia del termine "borderline"

Adolph Stern coniò il termine "borderline" per questi stati intermedi. Per decenni rimase una "diagnosi da cestino" (*wastebasket diagnosis*, **Knight, 1954**). **Kernberg (1967)**, **Grinker (1968)** e **Gunderson (1975)** iniziarono a definire criteri precisi. Il termine entrò nel **DSM-III nel 1980** come diagnosi indipendente.

Due significati di "borderline"

1. **Uso ristretto** (DSM): il disturbo borderline di personalità nel Cluster B.
2. **Uso estensivo (Kernberg)**: un'organizzazione intrapsichica — un livello strutturale che sottende molti disturbi gravi di personalità (grosso modo cluster A e B).

I tre livelli strutturali

Kernberg propone tre grandi organizzazioni strutturali su un continuum di gravità progressivamente minore:

Struttura	Integrazione identità	Meccanismi difensivi	Esame di realtà
Nevrotica	Ben integrata	Maturi	Conservato
Borderline	Diffusa (scissione)	Primitivi	Conservato (vacilla sotto stress)
Psicotica	Gravemente compromessa	Primitivi	Perduto/gravemente compromesso

Tre criteri per distinguere l'organizzazione borderline:

1. **Diffusione dell'identità**: il senso di sé e degli altri non è integrato. La persona non riesce a descrivere se stessa o le persone importanti in modo

coerente. Le percezioni cambiano radicalmente in base all'umore del momento.

2. **Meccanismi difensivi primitivi**: il meccanismo centrale è la **scissione** — tenere separati aspetti "buoni" e "cattivi" di sé e degli altri. Non esiste la zona grigia. Da qui derivano: idealizzazione primitiva, identificazione proiettiva, diniego, onnipotenza e svalutazione.
3. **Esame di realtà conservato**: a differenza della psicosi, la persona borderline riesce ancora a distinguere il dentro dal fuori, non delira in modo persistente. **Il contatto con la realtà può vacillare in momenti di forte stress, ma non è perduto.**

La lezione usa l'immagine del pacco regalo: l'organizzazione di personalità è la struttura interna (nevrotica, borderline, psicotica), mentre le etichette diagnostiche (paranoide, narcisistico, schizoide...) sono come la carta che avvolge il pacco — ciò che vediamo dall'esterno.

Trattamenti per il disturbo borderline

- **DBT** (Dialectical Behavior Therapy, **Linehan**): terapia di gruppo per esercitare la tolleranza alle emozioni, strategie interpersonali, gestione dello stress. Il programma più codificato e validato.
- **MBT** (Mentalisation-Based Treatment): lavora sulla capacità di comprendere i propri e altrui stati mentali.
- **TFP** (Transference-Focused Psychotherapy, **Kernberg**): lavora su quanto accade nella seduta come specchio dei pattern relazionali del paziente.

Miglioramenti sono possibili, ma la strada è lunga.

Domande esame 08

Sapere definire il concetto di temperamento, carattere e personalità.

Il **temperamento** è la base biologica della personalità: l'insieme dei tratti congeniti, biologicamente determinati e presenti dalla nascita, che stabiliscono il modo emotivo con cui un soggetto risponde al mondo esterno (Paris, 1997). È relativamente stabile ma influenzato anche da fattori prenatali e perinatali. Il **carattere** (dal greco *kharàssein*, "incidere, marchiare") è l'insieme dei tratti psicologici e comportamentali stabili che si sviluppano quando il bambino con il suo temperamento innato entra in contatto con l'ambiente e le esperienze di vita — viene "modellato" dalle relazioni. La **personalità** è il risultato dell'interazione tra temperamento e carattere: un insieme di modalità relativamente stabili di pensare, sentire, comportarsi e mettersi in relazione con gli altri (Lingiardi & McWilliams, 2018).

Conoscere i tratti di personalità definiti dalla teoria della personalità «Big Five».

Il modello Big Five di Costa & McCrae (1988) identifica cinque fattori della personalità, ognuno concepito come un continuum bidimensionale: (1)

Estroversione — quantità e intensità dei contatti interpersonali (contrapposta all'introversione); (2) **Nevroticismo** — tendenza all'instabilità emotiva e al turbamento (contrapposta alla stabilità emotiva); (3) **Gradevolezza** — calore emotivo, cooperazione, cordialità (contrapposta a egoismo e cinismo); (4)

Coscienziosità — autoregolazione, organizzazione, affidabilità, persistenza (contrapposta a impulsività e disorganizzazione); (5) **Apertura all'esperienza** — curiosità, immaginazione, ricerca del nuovo (contrapposta a inibizione e convenzionalità). Questi cinque fattori si aggiungono ai due di Eysenck (estroversione e nevroticismo) e ne costituiscono il successore più completo.

Conoscere i criteri generali che definiscono un disturbo di personalità.

Secondo il DSM-5-TR (APA, 2023), un disturbo di personalità è un pattern abituale di esperienza interiore e di comportamento che: (1) devia marcatamente rispetto alle aspettative culturali dell'individuo; (2) è pervasivo e inflessibile in un'ampia varietà di situazioni; (3) determina disagio clinicamente significativo o compromissione funzionale significativa; (4) è stabile e di lunga durata, con esordio nell'adolescenza o nella prima età adulta. Il pattern deve manifestarsi in almeno due di queste aree: cognitività, affettività, funzionamento interpersonale, controllo degli

impulsi. I tratti sono spesso **egosintonici** — la persona non li percepisce come problematici — il che rende difficile la motivazione al trattamento.

Conoscere i fondamenti alla base dei sistemi di classificazione nei quali si inseriscono i disturbi di personalità.

Il DSM-5-TR usa un approccio **categoriale** (presenza/assenza di criteri): i disturbi sono descritti come entità distinte, diagnosticabili quando vengono soddisfatti un numero minimo di criteri. Questo sistema facilita la comunicazione internazionale e la standardizzazione, ma presenta limiti importanti: alta comorbidità tra diagnosi (molti pazienti soddisfano criteri per più disturbi contemporaneamente), esclusione dei casi sotto soglia, e artificiosità delle categorie (i disturbi psicologici hanno natura dimensionale, non categoriale). In alternativa, il PDM-2 (Psychodynamic Diagnostic Manual, Lingiardi & McWilliams) propone un approccio più **dimensionale** e psicodinamico, che tiene conto dei processi mentali sottostanti oltre ai comportamenti osservabili. Kernberg propone invece la diagnosi **strutturale**, che classifica i disturbi su tre livelli di organizzazione intrapsichica (nevrotica, borderline, psicotica) indipendentemente dalla categoria sintomatica.

Sapere distinguere e descrivere i vari disturbi di personalità secondo le caratteristiche che troviamo nel DSM-5-TR.

Il DSM-5-TR raggruppa i disturbi di personalità in tre cluster. Il **Cluster A** (strani/eccentrici) comprende: paranoide (diffidenza e sospettosità pervasive, interpretazione malevola delle intenzioni altrui), schizoide (distacco dalle relazioni, gamma emotiva ristretta, non desidera relazioni strette), schizotipico (deficit sociali, distorsioni cognitive e percettive, eccentricità — il più vicino alla psicosi). Il **Cluster B** (drammatici/emotivi/imprevedibili) comprende: antisociale (violazione dei diritti altrui, assenza di rimorso, esordio prima dei 15 anni), borderline (instabilità di relazioni, identità e umore, marcata impulsività), istrionico (emotività eccessiva, ricerca di attenzione, seduttività inappropriata), narcisistico (grandiosità, bisogno di ammirazione, mancanza di empatia affettiva). Il **Cluster C** (ansiosi/inibiti) comprende: evitante (inibizione sociale, paura del rifiuto — desidera le relazioni ma le evita), dipendente (bisogno pervasivo di essere accuditi, sottomissione), ossessivo-compulsivo di personalità (perfezionismo, controllo, rigidità — senza ossessioni né compulsioni del DOC, egosintonico).

Saper illustrare il modo di intendere sé stessi e interpretare il mondo, così come i principali meccanismi di difesa di ciascun disturbo di personalità.

Ogni disturbo ha credenze patogene caratteristiche e meccanismi difensivi prevalenti (Lingiardi & McWilliams, 2018). **Paranoide**: sé = "sono costantemente in pericolo"; altri = "pronti ad attaccarmi"; difese: proiezione, identificazione proiettiva, diniego, formazione reattiva. **Schizoide**: sé = "amore e dipendenza sono pericolosi"; altri = "mi invadono"; difesa: ritiro. **Antisociale**: sé = "posso fare tutto ciò che voglio"; altri = "egoisti e spregevoli"; difesa: controllo onnipotente. **Borderline**: sé = "non so chi sono, privo di continuità"; altri = "tutti buoni o tutti cattivi"; difese: scissione, identificazione proiettiva, acting out, dissociazione. **Narcisistico**: sé = "devo essere perfetto per sentirmi bene"; altri = "hanno ricchezza e fama, più ne avrò io e meglio starò"; difese: idealizzazione e svalutazione. **Evitante**: sé = "sono in costante pericolo"; altri = "fonte di pericolo o protettori salvifici"; difese: evitamento, simbolizzazione, razionalizzazione. **Dipendente**: sé = "sono inadeguato, impotente"; altri = "forti e potenti, ho bisogno di loro"; difese: regressione, somatizzazione. **DOCP**: sé = "le emozioni sono pericolose e vanno controllate"; altri = "meno precisi, devo controllarli"; difese: isolamento degli affetti, intellettualizzazione, formazione reattiva.

Sapere mettere in relazione il disturbo borderline di personalità definito dal DSM-5-TR con l'organizzazione borderline di personalità di O. Kernberg.

Il DSM-5-TR descrive il disturbo borderline come una diagnosi specifica del Cluster B, caratterizzata da instabilità di relazioni, identità e umore con marcata impulsività. Kernberg usa invece il termine "borderline" in senso estensivo: come un **livello strutturale intrapsichico** che sottende molti disturbi gravi di personalità (grosso modo cluster A e B), non come una singola diagnosi. Il disturbo borderline del DSM è quindi un caso specifico dell'organizzazione borderline di Kernberg, ma l'organizzazione borderline include molto di più — è come la struttura interna di un pacco regalo, mentre la diagnosi DSM è la carta che lo avvolge.

Sapere spiegare il modello dei livelli evolutivi della personalità secondo O. Kernberg.

Kernberg propone tre grandi organizzazioni strutturali su un continuum di gravità progressivamente minore. L'**organizzazione nevrotica** ha identità ben integrata, meccanismi difensivi maturi e esame di realtà pienamente conservato.

L'**organizzazione borderline** si caratterizza per: (1) diffusione dell'identità — il concetto di sé e degli altri non è integrato, cambia radicalmente in base all'umore; (2) meccanismi difensivi primitivi — il meccanismo centrale è la scissione (tutto buono/tutto cattivo, senza zone grigie), con idealizzazione primitiva, identificazione proiettiva, diniego, onnipotenza e svalutazione; (3) esame di realtà conservato — a differenza della psicosi, la persona distingue ancora il dentro dal fuori, anche se il contatto con la realtà può vacillare sotto forte stress. L'**organizzazione psicotica** ha identità gravemente compromessa, meccanismi primitivi e esame di realtà perduto o gravemente compromesso.

Sapersi orientare a grandi linee nella gestione della relazione con questo tipo di utenza.

Lavorare con persone con disturbi di personalità richiede alcune consapevolezze fondamentali. Queste persone sono spesso egosintone — non percepiscono i propri tratti come problematici — e giungono ai servizi per altri motivi (crisi, richiesta dei familiari, sintomi sovrapposti come ansia o depressione). Chi ha un'organizzazione borderline utilizza difese primitive come la scissione e l'identificazione proiettiva: può idealizzare e poi svalutare l'operatore, o provocare reazioni emotive intense in chi lo assiste. È fondamentale mantenere la propria posizione senza essere risucchiati dalla dinamica relazionale e senza agire la controaggressività. I trattamenti validati per il BPD — DBT (Linehan), MBT e TFP (Kernberg) — mostrano che il miglioramento è possibile ma richiede lavoro lungo e costante. La diagnosi stessa, se comunicata con cura, può dare sollievo: sapere che la propria sofferenza ha un nome e che esistono percorsi specifici riduce il senso di isolamento.

Domande di orientamento allo studio

Qual è la differenza tra temperamento, carattere e personalità? Perché è importante per capire i disturbi di personalità?

Il temperamento è la base biologica, l'insieme dei tratti congeniti che stabiliscono il modo emotivo con cui una persona risponde al mondo — relativamente stabile e influenzato anche da fattori prenatali. Il carattere è l'insieme dei tratti acquisiti quando il temperamento innato entra in contatto con l'ambiente e le relazioni — viene "modellato" dall'esperienza. La personalità è il risultato dell'interazione tra temperamento e carattere. La distinzione è importante perché i disturbi di personalità derivano da tratti anormali (stabili, pervasivi), non da stati anormali temporanei. Il modello bio-psico-sociale di Paris (1997) spiega che la diatesi (vulnerabilità innata temperamentale) determina il tipo di patologia, mentre i fattori stressanti attivano questo potenziale.

Cosa distingue uno stile di personalità da un disturbo di personalità? Quali sono i criteri del DSM-5-TR?

Lo stile di personalità indica tratti presenti ma relativamente adattivi, che non compromettono significativamente il funzionamento. Il disturbo di personalità si configura quando i tratti sono così estremi e disadattivi da causare sofferenza significativa e compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree. Il DSM-5-TR richiede che il pattern sia: marcatamente deviante rispetto alle aspettative culturali, pervasivo e inflessibile, clinicamente significativo, stabile e di lunga durata, con esordio nell'adolescenza o nella prima età adulta. Il pattern deve manifestarsi in almeno due di queste aree: cognitività, affettività, funzionamento interpersonale, controllo degli impulsi.

Descrivi i tre cluster del DSM-5-TR e indica almeno un disturbo per ciascuno.

Il Cluster A raggruppa i disturbi detti "strani ed eccentrici", caratterizzati da diffidenza e isolamento: disturbo paranoide (sospettosità pervasiva, convinzione di essere perseguitato), disturbo schizoide (distacco dalle relazioni, gamma ristretta di emozioni), disturbo schizotipico (distorsioni cognitive e percettive, vicinanza all'ambito psicotico con esame di realtà ancora conservato). Il Cluster B raggruppa i disturbi "drammatici, emotivi, imprevedibili", con difetti nella regolazione emotiva: disturbo antisociale (violazione dei diritti altrui, assenza di rimorso), disturbo borderline (instabilità relazionale, identitaria e dell'umore), disturbo istrionico (ricerca di attenzione, emotività superficiale), disturbo narcisistico (grandiosità,

mancanza di empatia affettiva). Il Cluster C raggruppa i disturbi "ansiosi e inibiti": disturbo evitante (inibizione sociale per paura del rifiuto, ma desiderio di relazioni — contrariamente allo schizoide), disturbo dipendente (bisogno eccessivo di essere accuditi), DOCP (perfezionismo e controllo a scapito dell'efficienza, egosintonico a differenza del DOC).

Quali sono i tre criteri dell'organizzazione borderline secondo Kernberg e come si differenzia dalla struttura nevrotica e psicotica?

Kernberg descrive tre livelli strutturali su un continuum. L'organizzazione nevrotica ha identità ben integrata, meccanismi difensivi maturi e esame di realtà conservato. L'organizzazione psicotica ha identità gravemente compromessa, meccanismi primitivi e esame di realtà perduto. L'organizzazione borderline si caratterizza per: (1) diffusione dell'identità — il senso di sé e degli altri non è integrato e cambia radicalmente in base all'umore; (2) meccanismi difensivi primitivi — il meccanismo centrale è la scissione, tenere separati aspetti "buoni" e "cattivi" senza zona grigia; (3) esame di realtà conservato — a differenza della psicosi, la persona borderline distingue ancora il dentro dal fuori, anche se il contatto con la realtà può vacillare sotto stress intenso.

Cos'è la "costanza dell'oggetto" e perché la sua compromissione è centrale nel disturbo borderline?

La costanza dell'oggetto è la capacità di mantenere una rappresentazione stabile e integrata di una persona anche quando non è fisicamente presente — sapere che l'altro esiste e che ci vuole bene anche quando non è davanti ai nostri occhi. Nel disturbo borderline questa capacità è compromessa: se l'altro non è davanti agli occhi, c'è il vuoto. Questo spiega gli sforzi disperati per evitare l'abbandono (reale o immaginato): senza l'altro, la persona sente di non esistere. Spiega anche le relazioni intense e instabili con alternanza rapida di idealizzazione e svalutazione — l'altro è o tutto buono o tutto cattivo, senza integrazione degli aspetti contraddittori.

Concetti chiave

Termine	Significato
Temperamento	Tratti biologicamente determinati e congeniti; modulano la risposta emotiva agli stimoli
Carattere	Tratti acquisiti dalle relazioni e dall'esperienza
Personalità	Risultato dell'interazione tra temperamento e carattere
Tratto	Attributo psicologico stabile nel tempo e nelle situazioni
Stato	Condizione temporanea, spesso reattiva a eventi esterni
Corazza caratteriale	Meccanismi difensivi abituali, formati nella prima infanzia
Goodness of fit	Grado di armonia tra temperamento di una persona e il suo ambiente
Diatesi	Vulnerabilità innata che predispone allo sviluppo di un disturbo
Egosintonia	Il tratto è vissuto come coerente con sé stessi; non percepito come problema
Scissione	Meccanismo difensivo primitivo: tenere separati aspetti "buoni" e "cattivi"
Identificazione proiettiva	Proiettare sull'altro contenuti intollerabili + fare in modo che l'altro li "senta" e li faccia propri
Diffusione dell'identità	Senso di sé e degli altri poco integrato; percezioni contraddittorie
Organizzazione borderline	Livello strutturale con: diffusione identità + difese primitive + esame realtà conservato

Termine	Significato
Cluster A/B/C	Raggruppamenti DSM: A (strani/eccentrici), B (drammatici/emotivi), C (ansiosi/inibiti)

Collegamenti

- **Lezione introduttiva Salute Mentale:** il concetto di "pattumiera delle diagnosi" — i termini insulti attuali (idiota, deficiente, cretino) erano diagnosi cliniche dell'800. **Attenzione all'uso stigmatizzante delle categorie.**
- **Relazioni oggettuali:** nel disturbo borderline le relazioni sono di tipo anaclitico (d'appoggio). Cfr. lezioni su attaccamento.
- **Costanza dell'oggetto:** nel BPD è compromessa — se l'altro non è visibile, c'è il vuoto. Ripreso dalle prime lezioni sullo sviluppo.
- **Meccanismi di difesa:** concetto introdotto in lezioni precedenti, qui sistematizzato.
- **Prossima lezione:** sintomi dissociativi (derealizzazione, depersonalizzazione) — menzionati come spesso associati al BPD in momenti di forte stress.

⚠ Nota: il file "Wanda Winnipeg - È una bella giornata di pioggia.txt" risulta illeggibile per un problema nell'estrazione del PDF (testo invertito/a specchio). Se contiene materiale rilevante per l'esame, consultare il documento originale.